



DEFINICIÓN: Fiebre: $T \geq 38,3^{\circ}\text{C}$ (1 toma) o $\geq 38,0^{\circ}\text{C}$ sostenida $>1\text{ h}$ + **Neutropenia:** RAN $< 500/\mu\text{L}$ o $< 1000/\mu\text{L}$ con descenso esperable a $<500/\mu\text{L}$ en 48 h.
Aplicar también en afebriles con sepsis o hipotermia. **OBJETIVO:** ATB empírico en $<1\text{ h}$ sin esperar resultados.

1 EVALUACIÓN INICIAL · simultánea al inicio del antibiótico

Pruebas complementarias (TODOS)

- 2 hemocultivos · si CVC $\rightarrow$ 1 a través del catéter (*diferenciales*)
- Análítica: hemograma, función renal/hepática, iones, PCR + procalcitonina; + lactato si inestabilidad HD
- Rx tórax · sedimento + urocultivo

Según clínica: diarrea $\rightarrow$ coprocultivo + toxina *C. difficile*; viral $\rightarrow$ PCR respiratorios (SARS-CoV-2, influenza A/B, VRS); expectoración $\rightarrow$ cultivo esputo; infiltrado $\rightarrow$ antigenuria *S. pneumoniae* + *Legionella*; clínica neurológica $\rightarrow$ cultivo LCR.

Exploración física obligatoria

- Anamnesis dirigida por aparatos
- CVC: punto de inserción, trayecto subcutáneo, secreción, eritema, dolor
- Foco odontógeno · mucositis (grado)
- Foco perineal · partes blandas

Ingresado con fiebre persistente $>24\text{ h}$: hemocultivos de control cada 72 h.

2 ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO

ALTO RIESGO DIRECTO · ingreso obligatorio · **NO calcular MASCC:** LMA · TPH reciente · neutropenia esperada >7 días · QT intensiva reciente · CVC infectado · mucositis $\geq$ grado 2 · foco infeccioso · colonización/infección previa por BMR · signos de sepsis.

Escala MASCC (resto de pacientes)

Síntomas leves/ausentes	5	No hipotensión (TAS >90)	5
Síntomas moderados	3	No EPOC	4
Tumor sólido/linfoma sin IFI previa	4	No deshidratación	3
Ambulatorio al inicio	3	Edad < 60 años	2

MASCC ≥ 21 · BAJO RIESGO

Manejo ambulatorio si: estable 6–8 h en urgencias · 1.ª dosis ATB IV en urgencias · tolera VO · soporte familiar · $<1\text{ h}$ del hospital · cita en HdD a 48–72 h.

MASCC < 21 · ALTO RIESGO

Hospitalización + ATB IV.
Considerar también ingreso (aunque MASCC ≥ 21) si: esplenectomía · prednisona $\geq 20\text{ mg/d}$ · comorbilidad renal/hepática · CAR-T $< 2\text{ m}$.

3 TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO INICIAL

BAJO RIESGO · Vía oral

Amoxicilina/clavulánico 875/125 mg/8 h VO + Ciprofloxacino 750 mg/12 h VO
Alergia β -lactámicos: Levofloxacino 750mg/24h + IC Alergología.

ALTO RIESGO · SIN FOCO / SIN BMR / SIN SEPSIS · IV

Cefepime 2 g/8 h IV — o — Piperacilina/Tazobactam 4 g/6 h IV
Alergia β -lactámicos: Aztreonam 1 g/8 h + Vancomicina 10–15 mg/kg/8–12 h + IC Alergología.

CON FOCO INFECCIOSO · ESTRATEGIA DE ESCALADA · Ingreso siempre · ATB IV

Foco	Tratamiento de elección	Alergia β -lactámicos
Neumonía	Cefepime $\pm$ Azitromicina 500 mg/24 h (o Levofloxacino)	Levofloxacino 500mg/24 h
ITU	Cefepime 2 g/8 h	Aztreonam + Vancomicina
Mucositis	Piperacilina/Tazobactam 4 g/6 h	Aztreonam + Metronidazol 500 mg/8 h
Intraabdominal	Piperacilina/Tazobactam	Aztreonam + Metronidazol
Celulitis / partes blandas	Piperacilina/Tazobactam + Vancomicina (si riesgo SARM)	Aztreonam + Clindamicina 600 mg/8 h
SNC	Meropenem 2 g/8 h + Ampicilina 180 mg/kg/d	Aztreonam + Vancomicina 15–20 mg/kg/8–12 h
CVC	Cefepime + Vancomicina	Aztreonam + Vancomicina
Sinusitis	Piperacilina/Tazobactam	Aztreonam + Clindamicina

COLONIZACIÓN / INFECCIÓN PREVIA POR BMR · ESTRATEGIA DE DESESCALADA

Microorganismo	Tratamiento de elección
BLEE (clase B)	Meropenem 1g/8h en perfusión extendida 3 h
KPC (clase A)	Ceftazidima/Avibactam 2,5g/8h perf. ext. 3 h
OXA-48 (clase D)	Ceftazidima/Avibactam 2,5g/8h perf. ext. 3 h
NDM / VIM / IMP (clase B)	Ceftaz/Avibactam + Aztreonam (en Y) ó Aztreonam/Avibactam
<i>P. aeruginosa</i> XDR	Cefiderocol 2 g/8 h
<i>S. maltophilia</i>	Leve: Levofloxacino 750 mg/24 h · Grave: Cefiderocol + Levo
SARM	Vancomicina ó Daptomicina
<i>A. baumannii</i>	Cefiderocol 2 g/8h

Ceftaz/Avi y Cefiderocol carecen de actividad frente a anaerobios y cocos gram positivo $\rightarrow$ ampliar cobertura según foco. Considerar monitorizar niveles de vancomicina en debut LMA o sepsis, independientemente de la función renal

CRITERIOS DE SEPSIS · DESESCALADA

Triple terapia empírica IV en combinación:
 ▪ Meropenem 2 g/8 h en perfusión extendida 3 h
 ▪ Amikacina 15 mg/kg/24 h
 ▪ Vancomicina 15 mg/kg/12 h
 IRC: 1.ª dosis de carga plena, ajustar después.
 Si BMR previa: sustituir meropenem por la pauta dirigida (tabla BMR).

⚠ **ALERGIA β -LACTÁMICOS · regla general**
 Aztreonam 1 g/8 h + asociar según foco: Vancomicina (CVC, ITU, SNC) · Metronidazol (mucositis, abdominal) · Clindamicina (partes blandas, sinusitis). Solicitar siempre IC Alergología.

4 MONITORIZACIÓN Y EVOLUCIÓN · 48–96 h

48–72h · ESTABLE + cultivos NEGATIVOS

Afebril, mejoría inflamatoria $\rightarrow$ SUSPENDER ATB empírica o desescalar a VO, aunque persista neutropenia. Observación 24–48 h antes del alta.

48–72h · ESTABLE + cultivos POSITIVOS

Desescalar a ATB dirigido según antibiograma, aun con neutropenia. Si fiebre persistente $\rightarrow$ desescalada a criterio clínico.

INESTABLE clínica/HD

Ampliar a triple terapia (Meropenem + Amikacina + Vancomicina). Valorar IC UMI precoz.

Estable + fiebre persistente + cultivos NEG

Mantener ATB empírico inicial. Hemocultivos cada 48–72 h. Añadir Vancomicina si: sospecha CVC, antecedente SARM o cocos gram positivos. NO Amikacina sistemática.

PIEBRE PERSISTENTE $> 96\text{ h}$ · CONSIDERAR INFECCIÓN FÚNGICA INVASORA (alto riesgo). Solicitar: β -D-glucano + galactomanano séricos · TC torácico · FBC si imágenes sospechosas. Tratamiento empírico antifúngico (priorizar *pre-emptive*; iniciar empírico si TC/FBC se demoran $>48\text{ h}$):

- Sin profilaxis previa con azoles: Caspofungina 70 mg dosis carga $\rightarrow$ 50 mg/24 h IV · alt.: voriconazol o anfotericina B liposomal
- Con profilaxis activa con azoles · sospecha mucormicosis · inestabilidad HD: Anfotericina B liposomal 3–5 mg/kg/24 h IV
- Sospecha aspergilosis invasiva: Voriconazol 6 mg/kg/12 h IV $\rightarrow$ 4 mg/kg/12 h